随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

复习：

ttsx	骨骼肌（从浓度差切入）	心肌
轻度低钾血症	兴奋性↓（低钾血症最早的表现为肌无力）	兴奋性↑（心肌保护机制从通透性切入：低钾血症→膜对 K^+通透性↓/K^+电导↓）
严重低钾血症	兴奋性↓	兴奋性↓
轻度高钾血症	兴奋性↑	兴奋性↑（从浓度差切入）
严重高钾血症	兴奋性↓（去极化阻滞）（高钾血症骨骼肌先表现为感觉过敏、刺痛，后表现为肌无力）	兴奋性↓（去极化阻滞）（严重高钾血症和低钾血症都可导致心脏骤停）

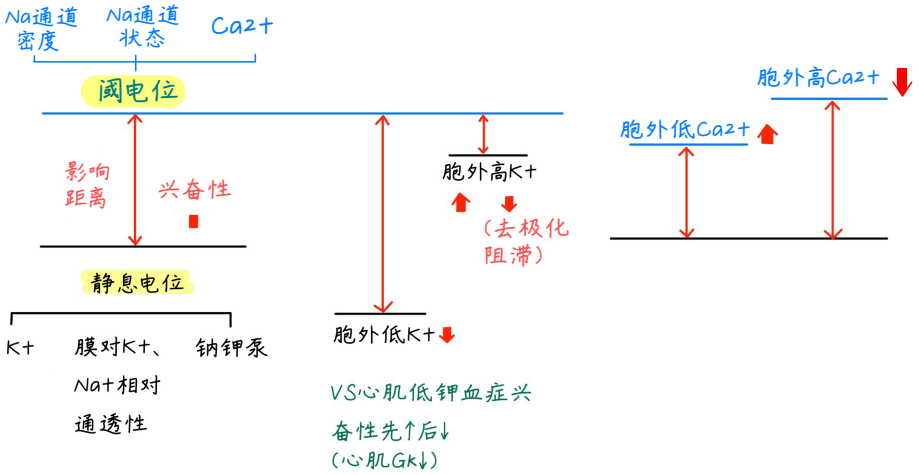
先↑后↓（心肌）

先↑后↓（骨骼肌）

串：葡萄糖酸钙拮抗 K^+对心脏的毒性

①严重高钾血症因膜电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙的 Ca^{2+}膜屏障作用使膜对 Na^+的通透性减小→阈电位与膜电位距离变远→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②Ca^{2+}内流↑→窦房结自律性↑、房室结传导性↑、工作细胞收缩性↑



（二）传导性

1.传导性的影响因素

（1）0 期去极化速度和幅度（主要）↑→传导性↑（形成的电位差大→局部电流强）

需注意 **0 期去极化速度和幅度的影响因素**（影响离子跨膜流动的因素，即动作电位的“全”）：**通透性/电导（钠或钙通道）、Na^+或 Ca^{2+}电-化学驱动力（膜电位-平衡电位）**磨平

快反应C　慢反应C

没有阈电位（决定动作电位的“无”，参考细胞电活动 2014N3）